Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Barra do Ribeiro

Rua Guilherme Hoff, 543, Cxa. P 13 - Bairro: Picada - CEP: 92870000 - Fone: (51)3098-3393 - Balcão virtual: (51)998537736 - Email: frbarrribevjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000046-41.2022.8.21.0140/RS

AUTOR: PALOMA SILVEIRA PINOS

RÉU: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento ajuizada por PALOMA SILVEIRA PINOS em face de UNIMED JOINVILLE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA. A autora narrou que foi diagnosticada com *neoplasia maligna de mama, CID10 C50*, tendo sido submetida a quimioterapia e retirada cirúrgica dos tumores da mama. Contudo, exames subsequentes revelaram a persistência de doença residual (Evento 1, INIC1, Página 4). Para o tratamento do seu grave quadro clínico, especialmente em virtude de sua idade, 38 anos à época, o médico assistente indicou o uso do medicamento *Capecitabina 500mg (nome comercial Xeloda)*, na posologia de 3 comprimidos, duas vezes ao dia, conforme receituário médico (Evento 1, INIC1, Página 5). A autora informou que o plano de saúde, mantido com a Unimed de Joinville, negou a autorização para o fornecimento do medicamento Capecitabina 500mg (Xeloda). A negativa, formalizada em 23 de dezembro de 2021 (Evento 1, OUT9, Página 1), fundamentou-se na alegação de que a indicação clínica informada pelo médico solicitante não estava descrita na bula do medicamento, caracterizando um uso "off label" e, por conseguinte, excluindo a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, conforme o Art. 17 da Resolução Normativa nº 465/21 da ANS. A ré alegou que a bula do medicamento Xeloda indicava seu uso para câncer de mama metastático, o que não seria o caso da autora, que apresentava doença residual sem metástase (Evento 1, INIC1, Página 6). A demandante refutou a tese de exclusão de cobertura, argumentando que a bula do medicamento não determina que se trata de indicação *totalmente* "off label", uma vez que o fármaco é efetivamente utilizado para câncer de mama. Ressaltou que, ainda que fosse considerado "off label", a prerrogativa de escolha do tratamento mais adequado para o paciente cabe ao médico assistente, que se baseia em modernos estudos e testes para garantir a maior chance de recuperação (Evento 1, INIC1, Página 6). Argumentou, ainda, que o medicamento possui registro na ANVISA, e que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo (Evento 1, INIC1, Página 7). No âmbito do Direito, a parte autora invocou a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei nº 9.656/98, que regulamentam os planos de saúde. Sustentou que o fármaco postulado é de cobertura obrigatória, enquadrando-se como medicamento antineoplásico oral (Art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei nº 9.656/98) e que a Lei nº 9.656/98 prevê a obrigatoriedade de custeio dos tratamentos relacionados a doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), na qual se insere a patologia da autora (Evento 1, INIC1, Página 7). Citou, ademais, o Art. 47 e o Art. 51, IV, § 1º, II do CDC, para defender a interpretação mais favorável ao consumidor e a nulidade de cláusulas abusivas que restrinjam direitos essenciais ao contrato. Adicionalmente, mencionou a Resolução Normativa nº 338, de 21/10/2013, que expressamente previa a cobertura para quimioterapia (Evento 1, INIC1, Página 8). A inicial também trouxe diversas ementas de julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Evento 1, INIC1, Páginas 9 a 15, que sustentam a abusividade da negativa de cobertura por uso "off label" ou por não constar no rol da ANS, especialmente em casos de câncer, reafirmando que a escolha do tratamento é prerrogativa do médico. Com base na urgência da situação e na probabilidade do direito, a autora requereu a concessão da tutela de urgência liminar, com fulcro no Art. 300 do CPC, para que a ré fornecesse o medicamento Capecitabina 500mg (Xeloda) no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de multa diária. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela, a procedência da ação para determinar o fornecimento contínuo do medicamento, a condenação da ré aos ônus sucumbenciais, a inversão do ônus da prova e a concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que se encontrava sem condições de laborar e recebia benefício do INSS (Evento 1, INIC1, Páginas 16-17, e Evento 1, DECL4, Página 1, comprovando o recebimento de auxílio-doença previdenciário).

O Juízo indeferiu a liminar resultou no indeferimento da liminar. Contudo, determinou a intimação da ré para se manifestar em 72 horas e sua citação (Evento 4, DESPADEC1, Página 1).

Inconformada com o indeferimento da liminar, a autora opôs embargos de declaração (Evento 12, EMBDECL1, Páginas 1-3), alegando omissão na análise de fatos e datas relevantes.

O Juízo acolheu os embargos de declaração da autora, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), especialmente em face do direito fundamental à saúde (Art. 196 da CF) e da comprovação da neoplastia maligna de mama, a magistrada deferiu a antecipação de tutela. Determinou o fornecimento do medicamento Capecitabina 500mg (Xeloda) pela requerida no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de bloqueio de valores para aquisição do fármaco (Evento 14, DESPADEC1, Página 1).

O benefício foi deferido em 24/01/2022 (Evento 25, DESPADEC1, Página 1). A comunicação eletrônica do cumprimento da carta precatória em Joinville/SC, informando a citação e intimação da Unimed, foi juntada em 28/04/2022 (Evento 43, OFÍCIO_C1, Página 1 e Evento 44, MAND1, Páginas 1-2).

Em 25 de janeiro de 2022, antes mesmo da juntada do comprovante de citação definitiva, a Unimed de Joinville apresentou manifestação sobre o pedido de antecipação da tutela (Evento 30, PET1, Páginas 1-9), reiterando seu desacordo com o deferimento da medida. Os argumentos foram a ausência de probabilidade do direito, uma vez que o medicamento Capecitabina 500mg (Xeloda) seria considerado "off label" para o tratamento da neoplasia maligna de mama nas condições da autora, não estando abrangido pela cobertura assistencial do contrato e da legislação vigente. A ré invocou a

Cláusula 5ª do contrato, que vincula as coberturas ao Rol da ANS e exclui expressamente medicamentos "off label", e o Art. 10 da Lei nº 9.656/98, que excetua tratamentos experimentais. A Resolução Normativa nº 465/21 da ANS, em seu Art. 17, inciso I, "c", foi citada para definir como experimental o uso "off label". A Unimed defendeu o caráter taxativo do Rol da ANS, conforme o Art. 2º da referida RN, e argumentou que a Autora não comprovou ato abusivo da Requerida.

A Unimed apresentou contestação (Evento 38, CONT1, Páginas 1-20), reiterando e aprofundando os argumentos já apresentados. Confirmou que a autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre a Unimed e a Cia. Latino Americana de Medicamentos. Reafirmou que o medicamento Capecitabina (Xeloda) é considerado "off label" para o tratamento da neoplasia maligna de mama nas condições da autora, uma vez que a bula (juntada como Evento 38, OUT3, Páginas 1-29) indica o medicamento para câncer de mama metastático, e não para doença residual sem metástase. A negativa de cobertura, portanto, seria um "exercício regular de direito" (Art. 188, I do Código Civil), amparado pelo contrato e pelo Art. 10, I, da Lei nº 9.656/98, e pela RN nº 465/21 da ANS. A ré defendeu a validade e intangibilidade do contrato, que prevê claramente a exclusão de cobertura para medicamentos "off label/experimental", e citou jurisprudência do STJ e do TJRS (conforme Evento 38, CONT1, Páginas 9-10) para sustentar a legalidade de cláusulas limitativas claras. Adicionalmente, argumentou sobre o descabimento da cobertura pleiteada em razão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, citando dados financeiros da cooperativa e manifestações da FENASAÚDE como "amicus curiae" em Recurso Especial (Evento 38, CONT1, Páginas 16-19), alertando para o risco de inviabilizar a atividade das operadoras. Por fim, requereu a improcedência da ação e a produção de provas, incluindo ofícios à ANVISA, CONITEC e ANS para obter informações técnicas sobre o medicamento e o posicionamento regulatório.

Em resposta à contestação e às provas requeridas pela ré, a autora apresentou manifestação em 09/03/2022 (Evento 41, PET1, Páginas 1-9), reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da ré. A autora enfatizou que o medicamento é utilizado para câncer de mama, mesmo que seu caso não envolva metástase, e que a Lei nº 9.656/98 assegura a cobertura de tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. Juntou, novamente, as ementas jurisprudenciais que defendem a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos "off label" e que não constam no rol da ANS, especialmente para tratamento de câncer.

Realizada audiência de mediação, restou inexitosa.

O juízo determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (Evento 75, DESPADEC1, Página 2). A ré requereu o oficiamento da ANVISA, CONITEC e ANS para obter informações sobre o registro, finalidade, uso para câncer de mama, forma de utilização, registros pendentes do medicamento Capecitabina (Xeloda), existência de estudos técnicos e recomendações de inclusão no rol do SUS, bem como o posicionamento da ANS sobre a legalidade da negativa de cobertura para medicamentos não previstos no rol (Evento 79, PET1, Páginas 1-3). A autora, por sua vez, peticionou informando que, graças à liminar deferida, o tratamento foi realizado com sucesso, com todos os ciclos necessários, e que estava há mais de dois anos com remissão da doença, sem sinais de recorrência, conforme laudo médico atualizado de 21 de junho de 2024 (Evento 80, PET1, Páginas 1-2 e Evento 80, LAUDO2, Página 1). A médica assistente, Dra. Lídia Niusca Bazanella Longhinoti, atestou que a paciente, Paloma Silveira Pinos, 40 anos, diagnosticada com câncer de mama triplo negativo em abril de 2021, foi tratada com quimioterapia neoadjuvante, cirurgia e radioterapia, e *foi tratada com capecitabina adjuvante durante 6 meses*. O laudo médico destacou que "O valor da capecitabina adjuvante se baseia no estudo de fase III CREATE X, que avaliou especificamente o papel de capecitabina adjuvante em mulheres que não atingem RCp após neoadjuvância (em geral com antraciclina e taxano)". A médica concluiu que "A paciente Paloma mantém seguimento clinico regular com consultas periódicas e exames imagem e se mantem livre de recorrência da doença oncológica", corroborando o êxito do tratamento (Evento 80, LAUDO2, Página 1). A autora defendeu que a questão é de direito, reafirmando que a recusa da operadora é abusiva, mesmo para uso "off label" ou não previsto no rol da ANS, quando necessário para doença coberta, e que a medicação funcionou perfeitamente. Por isso, requereu o julgamento procedente da ação, sem necessidade de mais provas (Evento 80, PET1, Páginas 1-2).

O juízo deferiu o pedido da ré para oficiamento à ANVISA, CONITEC e ANS (Evento 82, DESPADEC1, Páginas 1-2). A *CONITEC* respondeu em 21 de novembro de 2024 (juntada aos autos em 27/11/2024 - Evento 93, OFIC3, Páginas 1-6), informando que o medicamento capecitabina possui registros válidos na Anvisa para tratamento de câncer de mama metastático, câncer colorretal e câncer gástrico. Esclareceu que, até a presente data, *não há protocolado na Conitec pedido para análise de incorporação, no âmbito do SUS, do medicamento capecitabina* para tratamento de câncer de mama, seja por parte de fabricantes ou outros demandantes. A Conitec também sugeriu contato com a ANS, por se tratar de lide contra operadora de plano de saúde.

O juízo determinou a reiteração dos ofícios à ANVISA e à ANS, com previsão de entrega em mãos via Correios caso não houvesse resposta em 30 dias (Evento 103, DESPADEC1, Página 1). Os ofícios foram reiterados (Evento 104, OFIC1, Página 1 e Evento 106, OFIC1, Página 1). A *ANVISA* respondeu (juntada aos autos em 25/06/2025 - Evento 110, OFIC1, Páginas 1-8), por meio do Ofício nº 176/2025/SEI/DIRE2/ANVISA e Nota Técnica nº 77/2025/SEI/GGMED/DIRE2/ANVISA, e confirmou o registro do medicamento Xeloda (capecitabina) sob o número 189770004, com vencimento em 12/2028, bem como indicou as finalidades para as quais foi registrado, conforme bula. No que tange ao câncer de mama, as indicações são expressamente para "câncer de mama metastático, após falha da quimioterapia citotóxica com antraciclina" ou "câncer de mama metastático resistente a regimes de quimioterapia com paclitaxel e antraciclina". A ANVISA não informou sobre registro para câncer de mama não metastático, nem para doença residual localizada, conforme o caso da autora. Informou ainda que existem outros medicamentos com o mesmo princípio ativo registrados e que não há solicitação de registro pendente para o princípio ativo em questão. A ANVISA também ressaltou que "a escolha da adequação do tratamento é uma decisão médica, assim, é possível que um produto não seja considerado substituível por outro, ainda que ambos tenham a mesma indicação". Não houve resposta da ANS.

Após as respostas da CONITEC e da ANVISA, as partes foram intimadas a se manifestar. A parte ré (Evento 100, PET1, Páginas 1-3), manifestou-se sobre a resposta da CONITEC, reiterando que a ausência de pedido de incorporação do medicamento no SUS reforça a legalidade de sua negativa. Argumentou que a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento está condicionada à sua inclusão no rol da ANS ou no protocolo terapêutico do SUS, salvo comprovada ineficácia dos tratamentos padrão. A parte autora (Evento 101, PET1, Páginas 1-2), e reiterando posteriormente (Evento 117, PET1, Páginas 1-8), manifestou-se sobre as respostas dos ofícios. Afirmou que os ofícios comprovam que o medicamento

tem registro na ANVISA e é indicado para câncer de mama, doença que acometeu a autora, e que, portanto, não se trata de indicação *totalmente* "off label". Argumentou que o fato de não ter sido analisado pela CONITEC não afasta seu direito ao plano de saúde particular. Reafirmou que a liminar foi essencial e o tratamento obteve excelente resultado, comprovando a adequação do medicamento. Reiterou o entendimento do STJ sobre a abusividade da recusa em cobrir medicamentos "off label" ou não previstos no rol da ANS para doenças cobertas.

Após, a parte ré manifestou-se sobre a resposta da ANVISA, destacando que a agência confirmou que as indicações do Xeloda para câncer de mama são restritas a casos *metastáticos*, o que corroboraria sua tese de uso "off label" para a doença residual da autora. Defendeu que a prescrição para doença não metastática, mesmo com base em estudos clínicos como o CREATE X, enquadra-se como experimental e, portanto, excluída da cobertura contratual e legal. Reafirmou a licitude de sua negativa.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O feito transcorreu regularmente, não havendo nulidades ou irregularidades processuais a serem decretadas ou sanadas, tampouco preliminares a serem enfrentadas, em especial a alegada ilegitimidade passiva da autoridade coatora, que se confunde com o mérito, e por se aplicar a teoria da encampação ao caso concreto. Deste modo, passo, de imediato, à análise dos argumentos de mérito formulados pelas partes.

No caso objeto do presente feito, a parte autora comprova a condição de segurada da UNIMED (evento 1, DOC6), cabendo a este, portanto, o atendimento da demanda de saúde da requerente.

O laudo médico que intrui a inicial (evento 1, LAUDO8), firmado pelo médico assistente da parte autora, comprova a necessidade do tratamento requerido, diante do risco de óbito decorrente do agravamento do seu quadro de saúde:

RELATÓRIO MÉDICO

A Srta. Paloma Silveira Pinos, 38 anos, paciente acometida de neoplasia maligna de mama triplo negativo, grau 3, cuja IHQ Ki 67 60% RE - RP - HER2 escore zero demonstrou com diagnóstico em abril/21, CID10 C 50, com EC II A (cT2cN0cM0). Foi submetida a quimioterapia neoadjuvante com ACdd x 4 ciclos seguido de paclitaxel semanal + carboplatina até 13/9/21. Em 22/11/21 realizou setorectomia + PLS que evidenciou doença residual pos quimioterapia neoadjuvante (anatomo-patológico: carcinoma de mama invasivo de tipo não especial, residual 0,8 cm, 2 linfonodos negativos e margens livres. Painel de câncer hereditário (mendelics) mostrou ausência de variantes patogênicas.

Recomendo o uso de quimioterapia adjuvante com capecitabina durante 8 ciclos devido a paciente não ter atingido resposta patológica completa (RCp). Baseado no estudo de fase III CREATE-X que avaliou o papel de capecitabina adjuvante em mulheres que não atingem RCp após neoadjuvância (em geral com antraciclina e taxano) [publicado no N Eng J Med 376:2147, 2017]. Foram randomizado 900 pacientes para terapia-padrão *versus* quimioterapia adjuvante com capecitabina por 8 ciclos, o estudo mostrou aumento no Intervalo livre de doença (HR=0,70; IC de 95%: 0,53-0,93; p=0,00524) e na sobrevida global (HR=0,60; IC de 95%: 0,40-0,92; p<0,01) em favor do braço com capecitabina. Análise de subgrupo demonstrou que todo o ganho de Sobrevida livre de progressão ocorreu no grupo com tumores triplo-negativos (HR=0,58; IC de 95%: 0,39-0,87) em contraste com os tumores luminais (HR=0,84; IC de 95%: 0,57-1,23). Uma recente metanálise avaliou o papel de capecitabina no câncer inicial de mama em dados individuais de 15 mil pacientes de 12 estudos randomizados e mostrou benefício somente em pacientes com tumores triplo-negativos, reforçando os achados do CREATE-X [publicado no Breast Cancer Res Treat 179:533, 2020].

Dra. Lidia Niusca Bazanella Longhinoti
Oncologia Clínica
CRM/RS 24224

Lidia N. B. Longhinoti
CRM RS 24224
Oncologista Clínica

A negativa do demandado ao fornecimento do tratamento de que necessita a autora está comprovada nos autos, conforme documentos do evento 1, OUT9:

Esclarecemos que a cobertura assistencial do seu plano de saúde é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e o atendimento é realizado de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (lista de procedimentos), vigente nesta data. A lista de procedimentos está disposta no Anexo I da Resolução Normativa (RN) nº 465/21, observadas as exclusões de cobertura de acordo com o Art. 10 da Lei 9656/98.

Esta resolução estabelece em seu Art. 17, que os medicamentos cuja indicação clínica informada pelo médico solicitante não estiver descrita na bula/manual, será considerado off label, excluindo a obrigatoriedade de cobertura pela operadora de plano de saúde, segue artigo descrito abaixo:

Entretanto, a negativa não se justifica, pois se trata de situação excepcional e urgente, em que a operadora do plnao de saúde tem o dever de custear o tratamento com medicamento de uso *off-label* não constante no rol da ANS, pois não há substituto terapêutico eficaz no referido rol e a indicação médica estiver amparada em evidências que atestam sua eficácia para o quadro clínico do beneficiário.

O atendimento aos segurados deve ser amplo, incluindo atendimento médico, hospitalar e os atos necessários à prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, não podendo eximir qualquer procedimento.

Nesse sentido, há jurisprudência significativa que reconhece o dever da operadora de fornecer medicamentos mesmo que fora dos seus protocolos[1].

Restou demonstrado nos autos que houve ineficácia do tratamento quimioterápico convencional. Após a ministração da medicação, a parte autora teve remissão no avanço da doença (evento 80, LAUDO2):

> Relatório Médico
>
> A paciente Sra. Paloma Silveira Pinos, 40 anos, em abril de 2021 teve o diagnóstico de câncer de mama direita, CID C50. Tratava-se de carcinoma ductal invasor não especial, grau 3, T2N0MO, triplo negativo conforme estudo de imunohistoquímica que revelou: Ki67 60% RE negativo RP negativo HER2 escore zero. Foi tratada com quimioterapia neoadjuvante com protocolo ACdd seguido de paclitaxel e carboplatina até setembro de 2021. Realizou painel de cancer hereditario 37 genes (mendelics) com ausência de variantes patogênicas. Em novembro de 2021 foi submetida a setorectomia e pesquisa de linfonodo sentinela, cujo anatomopatológico mostrou carcinoma de mama invasivo de tipo não especial, residual de 0,8 cm, 2 linfonodos axilares negativos e margens livres. Realizou radioterapia da mama em junho de 2022. Foi tratada com capecitabina adjuvante durante 6 meses. O valor da capecitabina adjuvante se baseia no estudo de fase III CREATE-X, que avaliou especificamente o papel de capecitabina adjuvante em mulheres que não atingem RCp após neoadjuvância (em geral com antraciclina e taxano) [N Engl J Med 376:2147, 2017]. Tendo randomizado 900 pacientes para terapia-padrão versus QT adjuvante com capecitabina por 8 ciclos, o estudo mostrou aumento no intervalo liv re de doença (HR=0,70; IC de 95%: 0,53-0,93; p=0,00524) e na sobrevida global (HR=0,60; IC de 95%: 0,40-0,92; p<0,01) em favor do braço com capecitabina. Análise de subgrupo demonstrou que todo o ganho de sobrevida livre de doença ocorreu no grupo com tumores triplo negativos (HR=0,58; IC de 95%: 0,39-0,87) em contraste com os tumores luminais (HR=0,84; IC de 95%: 0,57-1,23). A paciente Paloma mantem seguimento clinico regular com consultas periódicas e exames imagem e se mantem livre de recorrência da doença oncológica.

Destarte, a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por PALOMA SILVEIRA PINOS em face de UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO para CONDENAR a parte ré ao fornecimento do tratamento à autora com a medicação Capecitabina 500mg (Xeloda), conforme prescrito pelo médico (evento xdxxx), sob pena de bloqueio de valores, e, portanto, **confirmo a tutela antecipada de urgência concedida**.

Sucumbente, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais pendentes.

IV. PROVIMENTOS FINAIS

Caso seja interposto recurso, intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo legal e, após, remeta-se ao Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Contadoria, para apuração de eventuais custas pendentes.

Havendo custas pendentes, encaminhe-se a guia à Central de Cobranças (CC). Saliento que, conforme Ato n.º 072/2022-P, a cobrança das custas finais do processo será integralmente realizada pelo Departamento de Receita-Serviço de Cobrança, do Tribunal de Justiça, cabendo ao Cartório a comunicação ao aludido órgão acerca da pendência de custas, mediante remessa da guia à Central de Cobranças (CC), na forma disponibilizada no sistema, caso a parte sucumbente não seja beneficiária da gratuidade judiciária.

Tudo atendido, baixem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Soares Mendes dos Santos, Juiz de Direito**, em 24/11/2025, às 16:29:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10094373045v8** e o código CRC **6a107382**.

---

1. Apelação Cível, Nº 50062359620208210013, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-08-2025; Apelação Cível, Nº 50222536620238210021, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-08-2025; Agravo de Instrumento, Nº 52466549220258217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 27-08-2025; Agravo de Instrumento, Nº 51233939020258217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 23-07-2025. ↩